

주사 없이 먹는 GLP-1, 어디까지 왔나

ACHIEVE-3 직접비교 리뷰

신약 오포글리프론 vs 기존 먹는 약 세마글루타이드 · 1,698명 52주 머리를 맞댄 비교 — 아직
국내 승인 전, 미리 함께 읽어보는 연구 결과입니다

왜 "더 편한 당뇨약"이 계속 나올까요

당뇨는 흔하고, 오래 가고, 꾸준히 챙기기가 가장 어렵기 때문입니다



한국 30세 이상 성인
당뇨병 유병률



65세 이상에서는
세 명 중 한 명

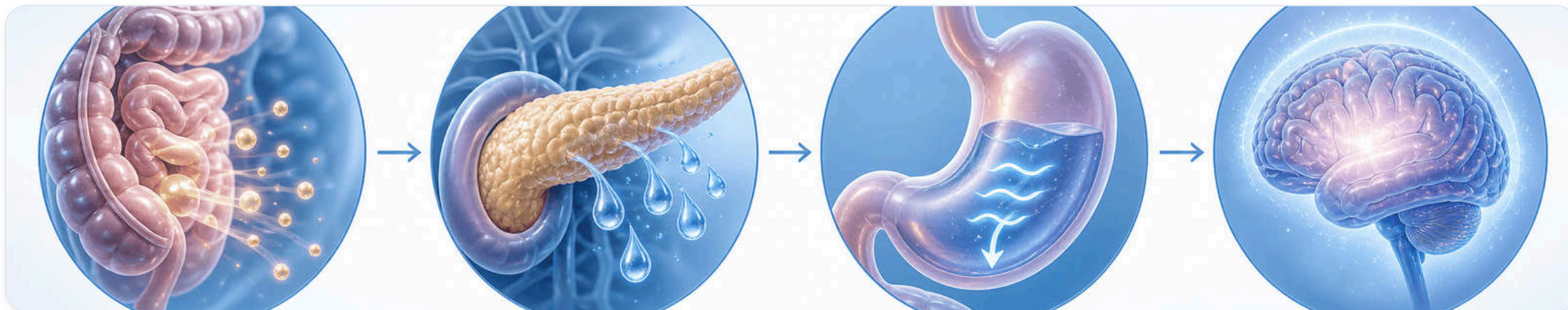


목표 혈당(당화혈색소)에
도달하는 비율

그래서 약이 진화합니다 — 당화혈색소(지난 2~3달 평균 혈당 성적표) 기준, 네 명 중 세 명은 아직 목표에 닿지 못합니다. 효과가 좋아도 맞기 불편하거나, 챙기기 번거로우면 오래 가지 못하죠. 주사로만 가능했던 GLP-1 치료가 "먹는 약"으로 바뀌고 있는 이유입니다.

GLP-1 — 식후 호르몬을 흉내 내는 약

원래는 주사로만 가능했던 치료입니다 — 약이 몸에서 하는 일은 세 가지입니다



1

식사를 시작하면

장에서 GLP-1 호르몬 분비 — 이 약이 그 역할을 더 강하고 길게 대신

2

인슐린 분비를 돕고

혈당 높을 때만 작동 — 저혈당 위험 없이 혈당을 내림

3

위를 천천히 비우고

식후 혈당 급상승 방지 — 메스꺼움이 생기는 이유이기도

4

식욕을 줄입니다

뇌 포만감 신호 보조 — 혈당·체중에 함께 작용하는 배경

앞 장의 그 GLP-1을, 주사 대신 알약으로 — 두 가지 방식

같은 계열이지만 알약을 만드는 기술이 다릅니다. mg 숫자는 서로 다른 약이라 직접 비교할 수 없습니다

기존 먹는 약(세마글루타이드)은 호르몬 조각(펩타이드)을 흡수보조제와 함께 삼키는 방식 — 그래서 빈속 규칙이 까다롭습니다.

신약 오포글리프론은 호르몬 조각이 아니라 작은 화학 분자(소분자)입니다. 처음부터 먹는 약으로 만들어 위산에 강하고, 흡수가 안정적이라 음식·물 제한이 없습니다. ACHIEVE-3는 이 두 알약을 같은 환자군에서 1년간 직접 비교한 첫 대규모 시험입니다.



같은 GLP-1 — 만드는 방식이 다른 두 알약

펩타이드 vs 소분자

기존 세마글루타이드(7·14mg)는 빈속 규칙 필요 · 신약 오포글리프론(12·36mg)은 음식·물 제한 없음 (국내 승인 전)

매일 아침이 달라집니다 — 복용 규칙 비교

두 약 모두 좋은 선택지입니다 — 다만 일상에 얹는 부담이 다릅니다



기존 먹는 약 · 세마글루타이드
빈속 규칙을 지켜야 효과가 납니다

- **아침 빈속에** — 물은 반 컵 이하로
- **복용 후 30분 금식** — 음식·음료·다른 약 대기
- **규칙을 지키면** — 검증된 혈당 강하 효과



신약 · 오폴글리프론 (국내 승인 전)
음식·물 제한 없이 하루 한 알

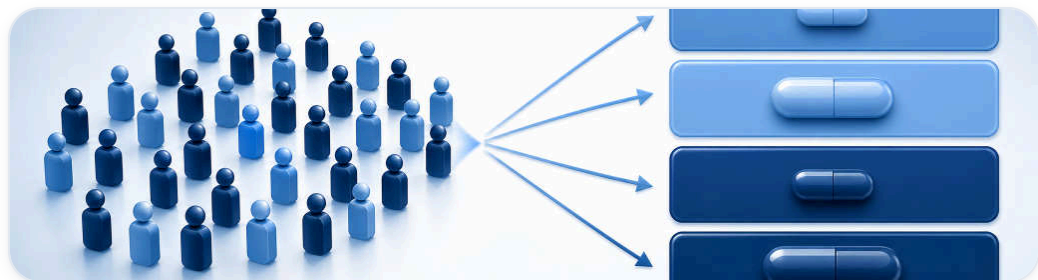
- **식사·물과 무관** — 하루 1회 아무 때나
- **금식 대기 없음** — 복용 후 바로 일상 그대로
- **대신 위장 적응 필요** — 메스꺼움 관리가 과제

1,698명이 1년간 — "머리를 맞댄" 직접비교란

다른 시험끼리 건너 비교한 게 아니라, 같은 조건의 환자를 무작위로 나눠 두 약을 정면으로 겨루게 한 연구입니다

대상 — 가장 기본 당뇨약(메트포르민)만으로는 혈당이 잘 안 잡히는 성인 2형 당뇨 (당화혈색소 7.0~10.5%, 과체중 이상).

5개국 131개 병원에서 환자를 모아, 네 가지 용량 그룹에 똑같은 인원수로 무작위 배정했습니다. 1형 당뇨·임신부는 해당되지 않으며, 한국인 별도 데이터는 아직 없습니다. 약을 가린 눈가림 시험이 아닌 **오픈라벨** 설계라는 점은 한계로 따로 살펴봅니다 (10장).



PARTICIPANTS

n = 1,698

5개국 131개 기관 · 4개 군 무작위 배정

FOLLOW-UP

52주

1차 평가 — 당화혈색소 변화 (시작 평균 8.3%)

결과 ① — 네 그룹 모두 내렸지만, 폭이 달랐습니다

당화혈색소(지난 2~3달 평균 혈당 성적표)의 1년 변화량, 시작 평균 8.3% — 막대가 길수록 많이 내린 것



막대 길이는 실제 감소폭에 비례합니다. 네 그룹 모두 의미 있게 내렸고, 신약이 같은 단계 용량끼리 비교했을 때 더 많이 내렸습니다 — 다음 장에서 그 차이를 봅니다.

결과 ② — 차이는 얼마나 컸나

"적어도 비슷한가"를 먼저 확인한 뒤(비열등성), "더 좋은가"까지 통과했습니다(우월성)

-0.44%p

ALL DOSE PAIRS SUPERIOR

네 가지 용량 조합 비교 모두에서 신약이 앞섰습니다. 심지어 낮은 단계의 신약(12mg)이 높은 단계의 기존약(14mg)보다 0.24% 포인트 더 내렸습니다 (용량 단계 기준 비교). 여기까지가 좋은 소식입니다 — 다음 장에서 "대가"를 함께 봅니다.

신약 36mg이 기존약 14mg보다 당화혈색소를 추가로 더 내린 폭 — 우연으로 보기 어려운 분명한 차이였습니다(통계적으로 확인). 개인마다 효과 크기는 다를 수 있습니다.

공짜는 없습니다 — 효과의 대가도 함께 봅니다

대부분 가볍고 시간이 지나며 줄어드는 증상입니다 — 다만 빈도는 신약이 더 높았습니다

GI · 01 

위장 증상

메스꺼움·설사 등 — 신약 100명 중 58~59명 vs
기존약 37~45명. 대부분 가벼운~중간 정도.

GI · 02

처음 몇 주에 집중

위가 약에 적응하는 시기에 주로 나타나고, 천천히
용량을 올리면 줄일 수 있습니다.

STOP · 03

복용 중단 — 약 2배

약을 끊은 비율 — 신약 100명 중 9~10명 vs
기존약 4~5명. 천천히 증량하면 줄일 수 있습니다.

HEART · 04 

맥박 소폭 증가

심장 박동이 분당 약 4~5회 증가 (기존약은
1~1.5회) — GLP-1 계열 공통으로 알려진
변화입니다.

CHECK · 05 

이런 분은 미리 상담

두근거림이 잦거나 심장질환·부정맥 병력이 있다면,
시작 전에 꼭 의사와 상의하는 것이 좋습니다.

TALK · 06

참지 말고 알리기

힘들면 용량 조절·중단 등 선택지가 있습니다 —
진료실에서 함께 해결합니다.

이 연구, 그대로 믿어도 될까 — 한계 네 가지

약 이야기는 여기까지 — 연구의 한계와, 가장 중요한 사실 하나

LIMIT · 01

오픈라벨 (눈가림 없음)

의사도 환자도 어떤 약인지 알고 진행 — 주관적 평가에 비뚤림이 끼어 들 수 있는 설계입니다.

LIMIT · 02

제조사(일라이 릴리) 후원

신약 개발사가 비용을 낸 시험입니다 — 결과 해석에 독립적 검증이 더해져야 합니다.

LIMIT · 03

52주 — 장기 데이터 아님

심혈관 보호 효과·수년 단위 안전성은 이 시험으로 알 수 없습니다. 별도 연구가 진행 중입니다.

LIMIT · 04

체중 효과는 아직 물음표

"살 빠지는 약"으로 기대하기 쉽지만, 이번에 공개된 연구 요약에는 체중 수치가 빠져 있습니다.

가장 중요한 사실 — 오폴글리프론은 아직 국내 미승인입니다. 처방·구매 불가, 해외 직구는 안전을 보장할 수 없습니다. 승인 소식은 저희가 챙겨 알려드립니다.

그래서, 오늘 할 일은 의외로 단순합니다

새 약을 기다리는 가장 좋은 방법은 지금 치료를 잘 유지하는 것입니다

- 1 지금 약 그대로 유지하기
드시던 당뇨약·인슐린을 임의로 끊거나 줄이지 않습니다.
- 2 직구·개인 구매 하지 않기
국내 미승인 약 — 광고·해외 사이트 구매는 위험합니다.
- 3 빈속 규칙 지키기
기존 먹는 약(세마글루타이드) 복용 중이라면 — 빈속 + 30분 금식 그대로.
- 4 혈당 수첩 가져오기
식전·식후 혈당을 기록해 다음 외래에서 함께 봅니다.
- 5 위장 증상 심하면 알리기
구역·구토·설사가 심하면 참지 말고 진료실에 연락합니다.
- 6 생활 습관 하나 정하기
이번 주 실천 한 가지 — 예: 한 끼 채소 한 주먹, 식후 10분 걷기.
- 7 신약 소식은 진료 때 묻기
승인·처방 가능 여부는 임의 판단 대신 의사와 상의합니다.

먹는 GLP-1 시대는 오고 있습니다

다만 아직은 준비 단계 — 그 사이 가장 좋은 약은, 지금 잘 유지하는 치료입니다

광교바른내과 진료 안내

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

☎ 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



이 자료 다시 보기